

VIVIEN LEAD MAGNET

10 jel, ami NEM demencia

*Önteszt és kompetens útmutató — egy
nyugodt szembenézés a memóriáddal*

KÉSZÍTETTE

Stoiber Vivien

Demenciaszakértő · A demenciáról érthetően

DEMENCIAROLERTHETOEN.HU

slug: 03-tiz-jel-ami-nem-demencia title: „10 jel, ami
NEM demencia" subtitle: Önteszt és kompetens
útmutató — egy nyugodt szembenézés a memóriáddal
audience: korai-jelek author: Galler-Mike Vivien
language: hu

10 jel, ami *NEM* demencia

Önteszt és kompetens útmutató

Egy *nyugodt* szembenézés a memóriáddal

Galler-Mike Vivien demencia szakértő

Kedves Olvasó!

Ha letöltötted ezt a füzetet, valószínűleg azért tetted, mert valami megijesztett. Talán a magad memóriájában vettél észre valamit. Talán az édesanyádén. Talán egy kolléga mondott valamit, ami azóta sem hagy nyugodni.

Először is: tedd le a telefont, és vegyél egy mély levegőt. Nem fogod most, ebben a percben eldönteni, hogy mi van veled vagy a szeretteddel. És ez teljesen rendben van.

Vivien vagyok, demencia szakértő, és napi szinten beszélek olyan emberekkel, akik *félnek*. Félnek, mert úgy érzik, valami nincs rendben. És sokszor — sokkal többször, mint gondolnád — kiderül, hogy nem demencia, hanem valami egészen más okozza a tüneteket. Alváshiány. Hormonális változás. B12-hiány. Stressz. Egy gyógyszer mellékhatása. Egy depresszió, amiről nem is tudtad, hogy ott bujkál.

Ez a füzet nem fog diagnózist adni — *nem is szabad*, hogy adjon. De abban segíteni fog, hogy:

- ne a Google találati listája dobáljon ide-oda hajnal háromkor,
- meg tudd különböztetni azokat a jeleket, amelyek valószínűleg semmi vészeset nem jelentenek, azoktól, amelyek miatt érdemes orvoshoz menni,
- legyen egy kis, *érthetően* felépített térképéd arról, hogy mi lehet a következő lépés.

A *tudás* nem garancia arra, hogy minden rendben lesz. De a *tudás* megnyugtatóbb, mint a félelem. És sokkal hasznosabb döntéseket lehet hozni belőle.

Olvasd lassan. Nem kell egyszerre végigmenni rajta. Tedd le, ha sok, és vedd elő holnap.

Szeretettel, Vivien

Három dolog, mielőtt belekezdész

1. A memória nem egységes — sokféle típusa van

Amikor azt mondjuk, „nem emlékszem”, az nagyon sok mindent jelenthet. Van *munkamemória* (amibe a mostani gondolatok férnek be — mondjuk amikor fejben összeadsz két számot), van *epizodikus memória* (a tegnap reggeli kávé íze), van *szemantikus memória* (a fővárosok, a gyerekkori számtáblázat), és van *procedurális memória* (hogyan kell biciklizni). Ezek mind külön agyi rendszerek, és különböző okokból tudnak akadozni.

Ha a munkamemóriád akadozik, mert három napja keveset alszol, az nem ugyanaz, mintha az epizodikus memóriád lyukad, és nem emlékszel, hogy tegnap nálatok volt-e a fiad.

2. A felejtés nem mind egyforma

A „nem találom a kulcsom” jelenség nagyon más, mint a „nem ismerem fel, mire való a kulcs” jelenség. Az első normális, mindenkivel megtörténik. A második már egészen más kategória. Ez a füzet abban segít, hogy ezt a két kategóriát ne keverd össze.

3. Aggódní nem szégyen, de tudni jobb, mint félni

Ha eljutottál idáig, hogy letöltesz egy ilyen füzetet, az nem hipochondria, hanem felelősségvállalás. Magadért, a szerettedért. De a *biztonság* nem a Google találati listáján kezdődik. Hanem ott, hogy lépésről lépésre, *érthetően* megnézed, mit jelentenek a tünetek.

10 jel, ami valószínűleg NEM demencia

A következő tíz oldalon olyan helyzeteket nézünk meg, amelyek a hétköznapiakban a leggyakrabban ijesztik meg az embereket — és amelyek legtöbbször *nem* demenciára utalnak. Mindegyiknél megmutatom, hogy mi lehet a valódi háttér, és mire érdemes figyelni.

Ez nem azt jelenti, hogy egyik sem lehet *soha* demencia kezdő jele. Hanem azt, hogy önmagában, alkalmanként, élethelyzettel összefüggésben — szinte mindig másról szól.

01 · „Elfelejttem, mit akartam mondani.”

Bemész a kollégád szobájába, és a küszöbnél elveszik a mondat. Vagy beszélgetés közben elnémulsz, mert kiment a fejedből, hova tartottál.

Mi áll mögötte legtöbbször: túlterhelt *munkamemória*. Ez a memória-fajta nagyon érzékeny a stresszre, az alváshiányra, és arra, ha túl sok minden történik egyszerre. Egy szakmai megbeszélés közepén, három e-mail mellett, két nyitott Excel-fülon — ez nem demencia, ez túlterhelés.

Mit segít: ha leírod a gondolatot, mielőtt megszólalsz; ha napi egy óra kommunikációs csendet hagysz magadnak; ha rendszeresen elalszol éjfél előtt.

Mikor más: ha nemcsak a mondat veszik el, hanem nem emlékszel rá, hogy egyáltalán mit beszéltetek öt perccel ezelőtt — akkor érdemes utánanézni.

02 · „Bemegyek a szobába, és nem tudom, miért.”

Ez talán a leggyakoribb „beijedés-trigger”. Mindenkiel megtörténik, és mégis mindenki magában titokban azt gondolja, hogy ez biztosan valami baj jele.

Mi áll mögötte: a tudományban ezt *doorway effect*-nek hívják (ajtókeret-hatás). Az agyunk a fizikai környezetváltozást használja arra, hogy „lezárja” az előző mentális kontextust, és újat nyisson. Ha átlépsz egy ajtón, az agy szó szerint „kitörli” a munkaasztalát. Ez nem hiba, ez egy memóriaszervezési mechanizmus, amit minden egészséges agy csinál.

Mit segít: semmi különös. Menj vissza arra a helyre, ahol az ötlet megszületett, és nagy valószínűséggel visszajön a gondolat.

03 · „Megint nem találom a kulcsom.”

Klasszikus. Kulcs, telefon, szemüveg, távirányító.

Mi áll mögötte: *figyelmi inattenció*. Amikor letetted, nem voltál ott figyelmileg. A telefonon beszéltél, a táskádat is letetted, a kutyát beengedted, és közben a kulcs landolt valahol. Az agyad nem rögzítette ezt az epizódot, mert nem volt rajta figyelem. Ez nem memóriaprobléma, hanem figyelem-elosztási kérdés.

Mit segít: „egy hely a kulcsnak” elv. Ne keresd magad a múltadban — építs egy szokást, és a memória onnantól nem szükséges.

Mikor más: ha *megtalálsz* a kulcsot, és nem ismered fel, hogy mire való, vagy ha furcsa helyen találsz meg ismétlődően (a hűtőben, a virágcserepben) — akkor érdemes utánanézni.

04 · „Néha keverem a neveket.”

A gyereket a kutyád nevére szólítod. A férjedet egy korábbi párod nevére. Vagy a saját testvéred nevére szólítod a barátnődet.

Mi áll mögötte: ezt a jelenséget *misnaming*-nek hívják, és tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy egészséges embereknél is teljesen normális, főleg gyors beszédben, érzelmi telítettségben, vagy amikor sokféle szerepet kell egyszerre játszani (anya, főnök, barát, gondozó). Az agyad nem a memóriát hibáztatja, hanem a „kategóriák közötti címkét” választja rosszul.

Mit segít: semmi. Mosolyogj rajta, és menj tovább.

Mikor más: ha rendszeresen *ugyanazt* a személyt nem tudod megnevezni, vagy ha közeli családtag nevét tartósan nem találod — akkor érdemes utánanézni.

05 · „Furcsa kódvesztések 45 után."

Negyvenöt és ötvenöt között hirtelen mintha valami megváltozna. A szavak kicsit lassabban jönnek elő. A koncentráció megcsuklik egy fontos megbeszélésen. Néha az érzés is megijesztő: „mintha köd lenne a fejemben".

Mi áll mögötte (nők esetében): a *perimenopauza*. Az ösztrogén hormonszint ingadozása közvetlenül hat a hippocampusra és a prefrontális kéregre — ez tudományosan dokumentált jelenség. A „menopausal brain fog" valós, mérhető kognitív hatás, ami a hormonális átmenet végeztével *vissza is rendeződik*. Nem demencia, és nem előzménye sem.

Mi áll mögötte (férfiaknál): csökkenő tesztoszteron, alvásminőség romlása (apnoe gyakran ekkor jelenik meg), életközepi stressz, gyakran felismeretlen depresszió.

Mit segít: nőgyógyász / endokrinológus konzultáció. Alvásvizsgálat. Pajzsmirigy-funkció ellenőrzése. Nem „smart drug", nem online kvíz.

06 · „Nem tudok semmire koncentrálni."

Olvasol egy bekezdést, aztán elveszik. Megnyitsz egy filmet, és tíz percenként a telefont nézed. A munkahelyi feladat, amit régen egy óra alatt megcsináltál, most egy egész napodat felemészt.

Mi áll mögötte: legtöbbször nem memóriaprobléma, hanem *figyelemproblémák*, amelyek mögött szinte mindig ott van valami — kiégés, depresszió, krónikus alváshiány, hosszan tartó stressz, vagy néha egy fel nem ismert ADHD, ami felnőttkorban válik először problémává.

A depresszió különösen alattomos, mert *pszeudodemenciát* tud okozni: a tüneti kép szinte ugyanaz lehet, mint egy enyhe kognitív hanyatlásnál — de a depresszió kezelésével *teljesen rendeződik*. Erről egy meta-elemzés is kimutatta: a felnőttkori depresszióval élők kognitív teljesítménye átlagosan jelentősen csökken, és a kezelés után visszaáll.

Mit segít: őszinte beszélgetés a háziorvossal a hangulati állapotról is, nemcsak a memóriáról. Sokszor itt nyílik meg az ajtó.

07 · „Mintha lemerült akkumulátor lennék.”

Reggel felkelsz, és máris fáradt vagy. Délben már nem tudsz gondolkodni. A szavak nehezebben jönnek, a türelem fogytán.

Mi áll mögötte: a *vitamin B12-hiány* a leggyakoribb, alulfelismerett oka az „enyhe kognitív tüneteknek” középkorúaknál és időseknél. Klinikailag is jól dokumentált, hogy a B12-hiány koncentrációs nehézséget, memóriaproblémát, és igen — pszeudodemenciás képet is okozhat. *Visszafordítható*, ha időben kiderül.

Ugyanígy:

- *vashiány* (különösen menstruáló nőknél),
- *D-vitamin hiány* (a magyar tél után szinte mindenkinél),
- *pajzsmirigy alulműködés* (hipotireózis) — szintén klasszikusan kognitív lassulást okoz.

Ezek vérvérből kiderülnek. Egy háziorvosi vérvétel többet ér, mint egy hetes Google-keresés.

Mit segít: vérkép. Komplet. Beleértve a B12-t, D-vitamint, ferritint, TSH-t.

08 · „Egész napos köd a fejemben.”

Olyan, mintha üvegfalon át hallanád a világot. Nem fáradtság — ez valami sűrűbb.

Mi áll mögötte: három gyakori magyarázat felnőtteknél:

1. **Alvási apnoé.** Éjjel öntudatlanul tízszer-hússzor abbahagyod a légzést, az agyad oxigénje csökken, és reggelre úgy ébredsz, mintha sosem aludtál volna. A partner gyakran már régóta panaszkodik a horkolásra. A diagnózis egy egyszerű alvásvizsgálat.
2. **Gyógyszer-mellékhatás.** Sok gyógyszer — antihisztaminok, néhány vérnyomáscsökkentő, altatók, izomlazítók, opioidok — okoz kognitív tompulást. Ha új gyógyszert kezdél, és azóta van a köd, ez nem véletlen. A *Beers-kritériumok* (idősebbeknél használt gyógyszer-ajánlási lista) konkrétan felsorolja, mely szerek növelik a kognitív zavar kockázatát.
3. **Long COVID.** Ha az elmúlt években átestél COVID-on, és azóta van a kognitív „köd” — ez ma már jól dokumentált entitás. Nem demencia, de valós, és van rá külön szakirodalom.

Mit segít: alvásvizsgálat, gyógyszer-revizíó a háziorvossal, türelem (a long COVID kognitív tünetei az esetek többségében javulnak).

09 · „Lassabban gondolkodom, mint régen.”

Hatvan után a feladatok, amelyek régen pár másodpercig tartottak, most egy kicsivel tovább. Az új technológiát nehezebb felvenni. A több feladat egyszerre már nem megy.

Mi áll mögötte: ez a *normális kognitív öregedés*. A feldolgozási sebesség az egyik leggyakrabban változó funkció, és ez nem patológia. A *kristályosodott intelligencia* (tudás, tapasztalat, szókincs) a legtöbb embernél hatvanas-hetvenes éveikben is megmarad, sőt, gyakran tovább gazdagodik. A *fluid intelligencia* (új problémák gyors megoldása) lassabban dolgozik — ez nem hiba, ez biológiai természet.

A *tudás* itt fontos: ha tudod, hogy ez normális, nem ijedsz meg tőle. És ha nem ijedsz meg, akkor nem szorongsz, és ha nem szorongsz, akkor a tényleges teljesítményed is jobb lesz. A szorongás ugyanis önmagában tud kognitív tüneteket okozni — ördögi kör.

Mikor más: ha nem a sebesség lassul, hanem már magát a feladatot sem érted (recept lépéseit, számla kitöltését, banki átutalást) — akkor érdemes utánanézni.

10 · „Egy ismerős szót nem találok.”

A nyelved hegyén van. Tudod, hogy tudod. Tudod, milyen betűvel kezdődik. De a szó nem jön elő.

Mi áll mögötte: ezt *tip-of-the-tongue* jelenségnek hívják, és minden egészséges felnőtt agynál előfordul. Vizsgálatok szerint heti egy-kettő ilyen élmény a felnőttkorban teljesen átlagos. Sőt: a kutatások szerint a kreatívabb, gazdagabb szókincsű embereknél *gyakrabban* fordul elő, mert nagyobb a „polc”, ahonnan a szót elő kell venni.

Mit segít: ne erőltesd. Ha hagyod, fél óra múlva magától beugrik. Ha ráerőltetsz, az agy a stressz miatt még jobban elzárja a hozzáférést.

Mikor más: ha visszatérően ugyanazt a hétköznapi tárgyat nem tudod megnevezni (pl. mindig elakadsz a „villa” vagy a „pohár” szónál), vagy ha körülírással kell helyettesítened mindennapi tárgyakat — akkor érdemes utánanézni.

10 jel, amivel viszont *értelmes* orvoshoz menni

Eddig azokat a helyzeteket néztük, amelyek a leggyakrabban ijesztenek meg, és legtöbbször másról szólnak. Most nézzük meg azokat, amelyeknél már valóban érdemes egy szakemberhez fordulni — háziorvos, neurológus, vagy memóriaszakrendelés.

Fontos: egyetlen jel önmagában, alkalmi előfordulással még nem feltétlenül jelent semmit. A figyelmeztető helyzet az, ha **több jel egyszerre, fokozatosan súlyosbodva** jelenik meg, és **befolyásolja a mindennapi életet**.

01 · Ugyanazt a kérdést rövid időn belül többször felteszi. Nem arról van szó, hogy elfelejti, és tíz perccel később újra rákérdez. Hanem hogy ugyanazt a választ percek alatt többször hallja — és minden alkalommal *újra* meglepődik rajta.

02 · Eltéved ismerős helyen. A megszokott útvonalon — bolt, templom, gyerek óvodája — váratlanul rossz irányba indul el, vagy nem tudja, hogyan érjen haza. Nem új helyen (az másnak is megesik), hanem *ismerősen*.

03 · Pénzügyi döntésekben furcsa hibák. Csekket többszöri kifizetése. Számlák kifizetetlenül maradnak. Pénzt küld telefonos „nyereményhez”. Korábban precíz, megbízható ember rendszeresen téveszt.

04 · Személyiség-változás, amit mások vesznek észre. A környezet azt mondja: „valami megváltozott rajta”. Türelmetlenebb lett, vagy ellenkezőleg — szokatlanul visszahúzódó. Régi szokásokat hagy el. Nem a memória a feltűnő, hanem az *ember*.

05 · Időbeli és térbeli dezorientáció. Nem tudja, hogy hétfő van vagy szombat, hogy reggel van vagy délután, hogy melyik évszak. Nem egyszer, nem álmos állapotban — hanem *tartósan*.

06 · Visszatérő megnevezési nehézség ugyanazon tárgyak körül. Nem az egyszeri „nyelvem hegyén van”. Hanem hogy mindig a *kanál*-nál akad meg, vagy mindig a *cipő* szót kell körülírni („az a dolog, amibe belebújok”). Tartós, ismétlődő, mindennapi tárgyaknál.

07 · Komplex, megszokott feladatok elhagyása. Egy receptet, amit harminc éve főz, már nem tud követni. A banki átutalás, amit egy éve még magabiztosan csinált, most kivitelezhetetlen. Nem új feladatok — *régi*, automatikus feladatok adják meg magukat.

08 · Hangulati labilitás váratlanul. Pillanatok alatt vált hangulatot, sokszor anélkül, hogy mi értenénk a kiváltó okot. Ez különbözik az életkori szomorúságtól vagy az ingerlékenységtől — *követhetetlen* a környezet számára.

09 · Új típusú szociális visszahúzódás. Régen szeretett közösségbe már nem megy. Telefont nem vesz fel. Korábbi hobbját abbahagyja — nem azért, mert nem érdekli, hanem mert *nem boldogul* vele többé, és ezt szégyelli. Ez gyakran az egyik legkorábbi jel, és sokáig „csak depressziónak” tűnik.

10 · A hozzátartozó veszi észre — mielőtt te észrevennéd. Ez talán a legfontosabb. A demencia korai szakaszában gyakori jelenség az *anozognózia* — az érintett őszintén nem érzékeli, hogy probléma lenne. Ha a házastársad, a gyereked, egy közeli barát ismételten szóra teszi, hogy „valami nem stimmel”, akkor ez önmagában *érdemes-orvoshoz-menni* jel — még akkor is, ha te magad teljesen rendben érzed magad.

Ha ezek közül **egy-kettő** időszakosan, élethelyzettel összefüggésben fordul elő — nem feltétlenül jelent semmit.

Ha **három vagy több** rendszeresen, hónapokon át, súlyosbodva jelen van — akkor érdemes orvosi konzultációval kezdeni.

Önteszt: Mi a következő lépés?

Ez nem klinikai szűrőteszt. Nem helyettesít MMSE-t, MoCA-t, vagy bármilyen orvosi vizsgálatot. Ez egy *döntésh*, ami abban segít, hogy a következő lépést tisztábban lásd.

Olvasd végig a kérdéseket, és számold, hány „igen” választ adsz.

Az elmúlt 6 hónapban...

1. Több mint háromszor előfordult, hogy ismerős helyen elbizonytalanodtál abban, merre kell mennie? ☐ igen ☐ nem
2. Volt olyan, hogy ugyanazt a kérdést ugyanannak az embernek rövid időn belül többször feltetted, és nem emlékeztél, hogy már megkérdezted? ☐ igen ☐ nem
3. Előfordult, hogy egy megszokott, rutin feladatban (recept, számla, technikai művelet) elakadtál úgy, hogy korábban nem akadtál volna el? ☐ igen ☐ nem
4. Mondta már neked valaki közeli — házastárs, gyerek, közeli barát —, hogy „mintha kicsit megváltoztál volna” az utóbbi időben? ☐ igen ☐ nem
5. Volt olyan eset, amikor visszatérően ugyanazt a hétköznapi tárgyat nem tudtad megnevezni, és körülírással kellett helyettesítened? ☐ igen ☐ nem
6. Tartósan (több hónapja) nem tudod nyomon követni az aktuális napot, dátumot vagy évszakot? ☐ igen ☐ nem
7. Olyan helyzetekből húzódtál vissza, amelyeket korábban szeretted, és úgy érzed, azért, mert már nem boldogulsz velük? ☐ igen ☐ nem

Eredmény-értelmezés

- **0–1 igen:** valószínűleg nincs miért aggódnod. Ha mégis nyugtalan vagy, a 7. oldali okok (alvás, vitamin, hormon, hangulat) felé érdemes először mozdulni.
- **2 igen:** érdemes átnézni a 7. és a 8. oldal magyarázatait, és először a *visszafordítható* okokat kizárni. Egy háziorvosi vérvétel jó kezdés.
- **3 vagy több igen:** érdemes egy *háziiorvosi konzultációval* kezdeni, ahol kifejezetten elmondod, mit tapasztaltál. A háziorvos eldöntheti, kell-e neurológiai vagy memória-szakrendelési továbbküldés. Ez nem diagnózis, ez egy *biztonságos* következő lépés.

- **Bármilyen eredmény, de a közeli környezeted ismételten jelzi, hogy valami megváltozott:** ezt önmagában is érdemes komolyan venni. A környezet sokszor előbb látja meg a változást, mint az érintett.

Amit a következő napokban *ne* csinálj

Ne keresd egész éjjel a Google-t.

Hajnal háromkor olvasott orvosi cikkek pontosan a legrosszabb állapotban érnek el. Az alváshiány önmagában rontja a kognitív teljesítményt — másnap úgy fogod érezni, hogy „még rosszabb a memóriád”. Pedig csak nem aludtál. A Google-keresést hagyd nappali órákra, és ne menj öt találatnál mélyebbre — onnantól már csak a szorongás dolgozik.

Ne vedd „smart drug”-ot vagy „memóriavitamin-csomagot”.

A piacon hemzsegnek a kétes hatású készítmények. Némelyik ártalmatlan, némelyik konkrétan ellenjavallt bizonyos gyógyszerekkel. Egy laboron alapú vérvétel és egy szakszerű hiánypótlás (ha indokolt) ezerszer többet ér, mint egy „nootropic” csomag.

Ne titkold el a házastársad / a gyereked / az orvosod elől.

Ez az egyik leggyakoribb hiba. A félelem azt mondja, hogy „majd ha biztos vagyok benne, akkor szólok”. De a *biztonság* nem egyedül születik meg. Egy közeli emberrel megosztva a félelem felére csökken — már attól, hogy kimondod. Az orvossal megosztva pedig egyenes út nyílik a konkrét válaszokhoz.

Ne dramatizáld, de ne is bagatellizáld.

Két véglet van. Az egyik: „biztos demencia, vége az életemnek”. A másik: „nem akarok belegondolni, majd elmúlik”. Egyik sem segít. A *nyugodt* középút az, hogy elismered: van itt valami, amire figyelek, és lépésről lépésre megnézem, mi az. Egyik héten egy vérvétel. Másik héten egy beszélgetés a párommal. Harmadik héten egy konzultáció.

Ne hasonlítgasd magad másokhoz.

„Az anyukámnál ez így kezdődött.” Lehet, hogy a te helyzeted másról szól. A demencia nem örökletes determinizmus, és nem minden memóriaprobléma demencia. A *tudás* az egyetlen biztos pont — nem a családi minta.

A következő lépés

Ha végigolvastad ezt a füzetet, már nagyon sokat tettél magadért. Egyszerű, *nyugodt* tudást szerezteél valamiről, amit eddig félve kerültél. Ez önmagában egy bátor lépés.

A következő, *gyakorlati* lépéshez itt van három lehetőség, kockázat-szintek szerint:

Ha 0–1 „igen” volt az öntesztben

- Pihenj. Több, mint gondolnád.
- Egy háziorvosi vérvétel (B12, D-vitamin, ferritin, TSH) jó alapozás bárkinek 40 felett.
- Ha nő vagy, és perimenopauza-időszakban — nőgyógyász konzultáció. A „brain fog” érdemi téma, nemcsak a hőhullám.

Ha 2 „igen” volt

- Háziorvosi konzultáció — célzottan, kifejezetten a tapasztalt tünetekkel.
- Alvásminőség értékelése (alvási apnoé-kockázat, alvásmennyiség).
- Gyógyszer-revízió: minden rendszeresen szedett szert nézzetek át, melyiknek lehet kognitív mellékhatása.

Ha 3 vagy több „igen” volt — vagy ha a környezet ismételten jelzi

- Háziorvosi konzultáció, amelynek célja kifejezetten a *további irányítás* (vérvétel, esetleg neurológiai vagy memóriaszakrendelési továbbküldés).
- Ha bizonytalan vagy abban, hogyan vezesd ezt a beszélgetést — vagy ha a szeretted nem akar orvoshoz menni —, akkor érdemes egy szakértői konzultációval előkészülni.

Ha szeretnél személyre szabott eligazítást

Vivien — *korai-jelek* konzultáció

Egy 60 perces beszélgetés, ahol átnézzük, mit tapasztalsz, milyen lépéseket érdemes a következő hetekben megtenni, és hogyan közelítsd meg a szerettedet, ha rajta látsz jeleket. Ez **nem orvosi diagnózis** — hanem egy szakértői térkép arról, hogy hol állsz, és merre érdemes indulni.

→ vivien.hu (placeholder) → hello@vivien.hu (placeholder)

Hivatkozott források és továbbolvasásra

A füzetben szereplő állítások mögötti szakirodalom. Nem teljes körű — válogatás azokból a forrásokból, amelyeket a leggyakrabban hivatkozok klienseimnek.

Általános korai jelek és differenciáldiagnózis

- Alzheimer's Association — *10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer's*
- NICE Guideline NG97 — *Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers*
- Mayo Clinic — *Dementia: Symptoms and causes*
- Petersen R. C. et al. — *Mild Cognitive Impairment: Concept and diagnosis*

Memória-mechanizmusok és „normális” felejtés

- Radvansky G. A., Copeland D. E. — *Walking through doorways causes forgetting (a doorway effect eredeti vizsgálata)*
- Brown A. S. — *A review of the tip-of-the-tongue experience*
- Salthouse T. A. — *Selective review of cognitive aging*

Perimenopauza és kogníció

- Maki P. M., Henderson V. W. — *Cognition and the menopause transition*
- Greendale G. A. et al. — *Effects of the menopause transition and hormone use on cognitive performance*

Depresszió és pseudodementia

- Kang H. et al. — *Comorbidity of depression and cognitive impairment*
- Sachs-Ericsson N., Blazer D. G. — *The new DSM-5 diagnosis of mild neurocognitive disorder and its relation to research in mild cognitive impairment*

B12, pajzsmirigy, alvás és visszafordítható okok

- Smith A. D., Refsum H. — *Vitamin B12 and cognition in the elderly*
- Samuels M. H. — *Thyroid disease and cognition*
- Bubu O. M. et al. — *Obstructive sleep apnea, cognition and Alzheimer's disease*

Gyógyszerek és kognitív mellékhatás

- American Geriatrics Society Beers Criteria — **potenciálisan nem megfelelő gyógyszerek időseknél**
- Campbell N. L. et al. — *The cognitive impact of anticholinergics*

Long COVID és kogníció

- Davis H. E. et al. — *Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations*

Hazai vonatkozás

- Nemzeti Demencia Stratégia (ahol elérhető hivatalos verzió)

- MeSAT — Memória- és Szellemi Aktivitás Teszt (használati keretek)

Rólam

Galler-Mike Vivien vagyok, demencia szakértő. Több mint egy évtizede dolgozom demenciával élő emberekkel és családjaikkal — gondozói, edukációs és tanácsadói szerepben egyaránt. A munkám középpontjában nem a betegség áll, hanem az ember és a család, akik együtt élnek vele.

Ezt a füzetet azért írtam, mert minden héten beszélek olyan emberekkel, akik hetek óta *félnek* — és kiderül, hogy a félelmükre nem orvos, hanem *megértés* és egy kicsi rendszerezett *tudás* a válasz. És minden héten beszélek olyanokkal, akiknek tényleg időben kell mozdulniuk — és nem tudják, hol kezdjék.

A célom, hogy ne kelljen senkinek egyedül megküzdenie ezzel a térképpel.

Kapcsolat

- [vivien.hu](#) (placeholder)
- hello@vivien.hu (placeholder)
- Korai-jelek konzultáció — 60 perc, online
- Hozzátartozói támogatás — egyéni és csoportos
- Cégeknek és intézményeknek — képzés, szupervízió

Ez a kiadvány nem helyettesít orvosi diagnózist. A benne foglaltak edukációs célt szolgálnak. Ha akut tünetet tapasztalsz — hirtelen kialakuló zavartság, beszédzavar, féloldali gyengeség, eszméletvesztés — azonnal hívd a 112-t.

© Galler-Mike Vivien · 2026